

इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस / ब्लैडर पेन सिंड्रोम

रोगी जानकारी · संक्रमण के बिना होने वाला दीर्घकालिक मूत्राशय दर्द और तत्कालिता

WARWIKI

इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, जिसे ब्लैडर पेन सिंड्रोम (IC/BPS) भी कहते हैं, एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें मूत्राशय या पेल्विक क्षेत्र में दर्द, दबाव या बेचैनी होती है और बार-बार या तत्काल पेशाब की ज़रूरत महसूस होती है — बिना किसी संक्रमण के। मूत्राशय भरने पर तकलीफ बढ़ती है और पेशाब करने के बाद कम होती है। एक-step इलाज न होने पर भी इसे अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सकता है।

इस स्थिति के बारे में

IC/BPS न तो संक्रमण है और न ही छूत की बीमारी। लक्षण हर व्यक्ति में अलग होते हैं और **flares** (तीव्र दौर) और शांत अवधियों में आते-जाते रहते हैं। सामान्य लक्षण:

- मूत्राशय या पेल्विस में दर्द, दबाव या बेचैनी
- दिन-रात बार-बार या तत्काल पेशाब की ज़रूरत
- मूत्राशय भरने पर तकलीफ **बढ़ती है**, पेशाब के बाद घटती है
- कुछ खाद्य पदार्थ, तनाव या मासिक चक्र से flare हो सकता है

कारण

सटीक कारण अज्ञात है। इसमें संवेदनशील मूत्राशय की परत, अति-संवेदनशील नसें और अक्सर **तनावग्रस्त पेल्विक फ़्लोर** की भूमिका होती है। इसलिए इलाज में आमतौर पर कई तरीके एक साथ अपनाए जाते हैं।

शब्दों को समझें

IC/BPS

इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस / ब्लैडर पेन सिंड्रोम — संक्रमण के बिना मूत्राशय दर्द और तत्कालिता।

Flare

लक्षणों का तीव्र दौर, जो अक्सर खाने या तनाव से शुरू होता है।

Diagnosis of exclusion

अन्य कारण (जैसे संक्रमण) नकारने के बाद निदान।

Pelvic-floor therapy

तनी हुई पेल्विक मांसपेशियों को ढीला करने की physical therapy।

Bladder instillation

पतले catheter से मूत्राशय में आरामदेह दवा डालना।

Hunner lesion

कुछ लोगों में मूत्राशय की दीवार पर एक विशेष थब्बा, जिसका सीधा इलाज हो सकता है।

Cystoscopy

पतले कैमरे से मूत्राशय के अंदर देखना।

क्या यह ठीक होगा? IC/BPS आमतौर पर दीर्घकालिक होता है, लेकिन अधिकांश लोग इलाज और trigger पहचानकर काफी राहत पाते हैं। लक्ष्य है — कम और हल्के flares और सामान्य दैनिक जीवन। इसमें थोड़ा समय और धैर्य लग सकता है।

जाँच कैसे होती है

कोई एक test नहीं है। अन्य कारण नकारने के बाद लक्षणों से निदान होता है:

- संक्रमण या खून को नकारने के लिए **urine test**
- लक्षण इतिहास और **bladder diary**
- कभी-कभी Hunner lesion देखने के लिए **cystoscopy**

इलाज कैसे होता है (चरणबद्ध)

- 1 **स्व-देखभाल** — अपने **food triggers** पहचानें, तनाव व नींद सुधारें, gentle bladder training करें।
- 2 **Pelvic-floor physical therapy** — तनी मांसपेशियों को ढीला करने के लिए (ज़ोरदार Kegels से स्थिति बिगड़ सकती है)।
- 3 **दवाएँ** — मौखिक दवाएँ और आरामदेह **bladder instillations**।
- 4 **लक्षित & उन्नत देखभाल** — Hunner lesion का इलाज, या गंभीर मामलों में nerve stimulation।

IC/BPS के साथ जीना

- सामान्य triggers: **कॉफी, चाय, शराब, खट्टे फल, टमाटर और मसालेदार खाना** — एक-एक हटाकर और वापस लेकर अपना trigger जानें।
- एक **flare plan** रखें (आराम, गर्मी, पानी, सुपाच्य खाना)।
- तनाव और तनी पेल्विक फ्लोर से स्थिति बिगड़ती है — हल्का व्यायाम और relaxation से राहत मिलती है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार, ठंड लगना या पीठ/पसली में दर्द (संभावित संक्रमण)
- पेशाब में **नया खून**
- बेकाबू flare, या पेशाब न हो पाना

याद रखने योग्य तीन बातें

1. IC/BPS संक्रमण **नहीं** है — मूत्राशय/पेल्विक दर्द और तत्कालिता की दीर्घकालिक, पर नियंत्रणीय स्थिति है।
2. इलाज में स्व-देखभाल, trigger नियंत्रण, pelvic-floor therapy, दवाएँ/instillations और लक्षित देखभाल शामिल हैं।
3. अपने food और तनाव triggers जानें, flare plan बनाएँ। पेशाब में नया खून, बुखार या पसली में दर्द होने पर जाँच कराएँ।